RESPIRATOIRE EN CARDIOVASCULAIRE REVALIDATIE

Overzicht samenvatting van GC

Jacco van der Meulen
Fysiotherapie

INHOUDSOPGAVE

GC College week 1 ..... **2**

Gc college week 3 ..... **6**

GC College week 5 ..... **10**

GC COLLEGE WEEK 1

Context en Cijfers
Harde Cijfers:
- Op 1 januari 2021 hadden 10,3 miljoen Nederlanders 1 of meer chronische aandoeningen (59%).
- 2021: 545.900 mensen met COPD (270.600 mannen; 275.300 vrouwen).
- 2021: 1,7 miljoen mensen met hart- en vaatziekten (936.900 mannen; 767.200 vrouwen).
- Elk jaar sterven 12.000 mensen vroegtijdig door een vorm van luchtvervuiling!

Het Ziekteproces
- Personen met een ziekte doorlopen vaak fasen, waaronder:
- Onzekerheid: Men probeert de betekenis en ernst van de eerste symptomen te begrijpen.
- Verstoring: Het wordt duidelijk dat ze een significante ziekte hebben. Men ervaart een crisis die wordt gekenmerkt door intense stress en een hoge mate van afhankelijkheid van gezondheidswerkers en/of andere mensen die emotioneel dicht bij het individu staan.
- Streven naar herstel: Men probeert een vorm van controle over hun ziekte te krijgen door middel van actieve coping.
- Herstel van welzijn: Een nieuw emotioneel evenwicht bereiken op basis van een acceptatie van de ziekte en de gevolgen ervan.

Ziekte en Fysieke Uitkomsten
- Vermoeidheid: Komt vaak voor bij veel chronische aandoeningen en is bij velen geassocieerd met angst en depressie.
    - Vermoeidheid wordt consequent geassocieerd met een verminderde Kwaliteit van Leven (KvL).
- Immuun-veranderingen: Worden veroorzaakt door acute stress.

Emoties en Psychologische Reacties op Ziekte
Emoties rondom Ziekte:
- Positief:
    - Het bevorderen van psychologische veerkracht en effectievere probleemoplossing.
    - Het wegnemen van negatieve emoties.
    - Het opwekken van een opwaartse spiraal van positieve gevoelens.
- Negatief:
    - Omvatten hogere nood, depressie en angst.
    - Verlies van controle en onafhankelijkheid.
    - Verlies van 'je eigen ik', teleurstelling.

Winst door Ziekte (Posttraumatische Groei):
Er zijn vijf domeinen van positieve verandering als gevolg van stress of trauma geïdentificeerd:
- Verbeterde persoonlijke relaties
- Grotere waardering voor het leven
- Een gevoel van toegenomen persoonlijke kracht
- Verhoogde spiritualiteit
- Een verandering in prioriteiten en doelstellingen in het leven

Copingstrategieën:
- Probleemgerichte coping: Doel: impact van de stressor verminderen of mogelijkheden om met stressor om te gaan vergroten.
- Vermijdende coping: Doel: reguleren van emotie door confrontatie met stressvolle situatie te vermijden.
- Emotiegerichte coping: Doel: omgaan met emoties en gedachten die stressor oproepen.

Kwaliteit van Leven (KvL)

Definitie KvL:
- Kwaliteit van Leven (KvL), Quality of Life (QoL): De evaluatie van een individu van zijn algehele levenservaring op een bepaald moment (wereldwijde kwaliteit van leven).
- Gezondheidsgerelateerde QoL: Evaluatie van levenservaring en hoe deze wordt beïnvloed door ziekte, ongevallen of behandelingen.
- Volgens de WHOQOL werkgroep (1993, 1994): QoL is de perceptie van een persoon van zijn positie in het leven in relatie tot zijn culturele context en de waardesystemen van die context en hun eigen doelen, normen en verwachtingen.

Onderdelen KvL:
- Lichamelijke gezondheid: pijn, ongemak; energie / vermoeidheid; slaap, rust.
- Psychologische gezondheid: positieve gevoelens; zelfvertrouwen; denken, geheugen, leren en concentratie; lichamelijk beeld en uiterlijk; negatieve gevoelens.
- Niveau van onafhankelijkheid: activiteiten van het dagelijks leven (bijv. zelfzorg); mobiliteit, medicatie en behandelafhankelijkheid; werkcapaciteit.
- Sociale relaties: persoonlijke relaties; praktische sociale ondersteuning; seksuele activiteit.
- Omgeving: bijv. fysieke veiligheid en beveiliging; financiële middelen; thuisomgeving; beschikbaarheid / kwaliteit van gezondheid / sociale zorg; leermogelijkheden; vrijetijdsparticipatie / kansen.
- Spiritualiteit, religieuze en persoonlijke overtuigingen.

Factoren die KvL Beïnvloeden:
- Demografie: bijv. leeftijd, cultuur.
- De toestand zelf: b.v. symptomen, aanwezigheid of afwezigheid van pijn, functionele handicap, neurologische schade met bijbehorende motorische, emotionele, cognitieve, sensorische of communicatieve stoornis.
- Behandeling: b.v. beschikbaarheid, aard, omvang, toxiciteit, bijwerkingen.
- Psychosociale factoren: bijv. emoties (angst, depressie), coping, sociale context, doelen en ondersteuning.

Focus op COPD
- Prevalentie en Oorzaken:
  - Prevalentie: ♂️ 31 op de 1000; ♀️ 31,2 op de 1000.
  - Oorzaken:
    - Roken (80-85% van de reguliere rokers krijgt COPD).
    - Erfelijke aanleg.
    - Luchtverontreiniging (meeroken; fijnstof; koolstofdioxide; zware metalen).

Fysieke Aspecten COPD:
- Kortademigheid; minder bewegen, afname conditie.
- Hoesten: pijn, vermoeidheid, schaamte, isolatie.
- Gewicht: afname of toename (door prednison).
- Beperking in activiteiten.

Emotionele Aspecten COPD:
- Isolatie door passief roken te vermijden.
- Angst voor benauwdheid, toekomst, achteruitgang.
- Conflicten; ziekte niet altijd waarneembaar.

Psychische Aspecten COPD:
- Boosheid en Machteloosheid.

- Negatief zelfbeeld.
- Angst voor controleverlies, door toenemende afhankelijkheid van anderen.
- Angst om te stikken.
- Depressie.
- Verandering Sociale Rol: van gezonde naar zieke.
- Geheugen- en concentratiestoornissen.

Anamnese en Meetinstrumenten bij COPD
Anamnese Punten:
- Hulpvraag & Verwachtingen
- Motivatie & Informatiebehoefte
- Kwaliteit van leven
- Copingstrategie & Locus of control
- Belasting / belastbaarheid
- Participatieproblemen

Aanbevolen Meetinstrumenten (Bron: KNGF richtlijn COPD):
Aandoening/ziekte: COPD
- Functies en anatomische eigenschappen: diagnostisch/evaluatief: 6MWT, CPET[1], saturatiemeter.
- Activiteiten: diagnostisch/evaluatief: activiteitenmeter, PSG.
- Participatie: diagnostisch/evaluatief: PSG.
- Externe factoren: diagnostisch/prognostisch/evaluatief: (geen specifieke genoemd)
- Persoonlijke factoren: diagnostisch/evaluatief: CCQ of CAT [2].
- *([1]CPET: Cardiopulmonale inspanningstest; [2]CCQ: Clinical COPD Questionnaire, CAT: COPD Assessment Test)*

Behandeling en Revalidatie bij COPD
- Longrevalidatie: Doelen en Interventies:
- *Doelen:*
  - Verminderen kortademigheid.
  - Verbeteren inspanningstolerantie, sociale en fysieke activiteiten.
  - Verbeteren kwaliteit van leven.
- *Interventies:*
  - Stoppen met roken (psychologische en farmacologische ondersteuning).
  - Medicatie, luchtwegverwijders.
  - Behandeling met zuurstof.
  - Voedingstoestand optimaliseren.
  - Fysiotherapie.
  - Psychosociale begeleiding.

Focus van de Behandeling:
- Voorlichting: omtrent de pathologie.
- Coping: zelfmanagementtraining (meer verantwoordelijkheid nemen in de besluitvorming omtrent de longklachten).
- Zelf-management.
- Verbeteren kwaliteit van leven: middels Cognitieve gedragstherapie (afleren van de angst om te bewegen, verminderen van vermijdingsgedrag, leren omgaan met stress).
- Gedragsverandering: roken, aanleren gezonde leefgewoonten.
- Ontspanningsoefeningen.

Belangrijke Aspecten bij Begeleiding:
- Overbelasting.

- Onderbelasting.
- Gemoedstoestand (rouwverwerking).
- Accepteren van aanpassingen (gezichtsverlies, rouwverwerking).
- Veilige omgeving bieden.

Rouwverwerking en Acceptatie - Kübler-Ross Model:
- Heftige emoties kunnen kortademigheid luxeren (uitlokken).
- Vooral COPD patiënten ervaren een opeenvolging van verlieservaringen.

Fasen (kunnen door elkaar lopen, niet strikt lineair):
1. Ontkenning
2. Boosheid
3. Onderhandelen (Marchanderen)
4. Depressie
5. Acceptatie

Kübler-Ross Fasen Uitgelegd (Verandercurve):
- Schok: Verstijfd door het slechte nieuws. Geef tijd om het door te laten dringen.
- Ontkenning: Doen alsof er niets is gebeurd. Maak het onmogelijk het te negeren.
- Woede: Mopperen over hoe oneerlijk het is. Toon geen overreactie. Wacht tot alle stoom uit de ketel is.
- Marchanderen: Proberen te onderhandelen over alternatieven. Toon ze dat verandering onvermijdelijk is.
- Depressie: Realiseren zich: de verandering komt. Wees geduldig en laat ze treuren.
- Aanvaarding: (Partiële) Aanvaarding van de verandering. Ondersteun ze door bevestiging.

Signalen van Suboptimale Acceptatie:
- Teveel aandacht schenken aan zaken die in conflict zijn met de beperking.
- Ervaren dat je slechter af bent sinds de gebeurtenis.
- Sterke negatieve emoties.
- Vermijding van confrontatie met de beperking.
- Wanhopig naar hulp zoeken.
- Lage therapietrouw.

Factoren voor Positieve Verwerking:
- Open communicatie.
- Eerder goed reagerend op calamiteiten.
- Goede huwelijks- en gezinsrelatie.
- Gebruik natuurlijke hulpbronnen als buren, vrienden.
- Religieuze oriëntatie.
- Afwezigheid van andere belasting.
- Houding van “carpe diem”.
- Beste zorg moet beschikbaar zijn.

Communicatie met Patiënten
Niet te veel informatie ineens en voor patiënt in logische volgorde presenteren.
Voorlichting moet rekening houden met eigenschappen van patiënt en sociale omgeving.
Regelmatig nagaan of en welke problemen patiënten ervaren bij huiswerkoefeningen of gedragsveranderingen.

GC COLLEGE WEEK 3

College Groepsdynamica: Gedrag en Communicatie (FT-zorg 7)

Relevantie voor Fysiotherapie
- Dit college behandelt groepsdynamica, wat relevant is voor fysiotherapeuten die vaak groepen begeleiden, zowel in de eerste als tweede lijn. Voorbeelden zijn revalidatiegroepen na hartoperaties, COPD-patiënten, maar ook groepen met fibromyalgie, chronische pijn of obesitas.

Het doel is inzicht te krijgen in:
- De processen die plaatsvinden tijdens groepsinteractie en groepsvorming. Het is belangrijk te begrijpen dat een groep meer is dan een verzameling individuen; er zijn processen nodig om een echte groep te vormen.
- De kwaliteiten die nodig zijn om groepen effectief te kunnen leiden.

Wat is Groepsdynamica?
Groepsdynamica is het vakgebied dat zich bezighoudt met het functioneren van groepen, inclusief het gedrag en de interacties van de groepsleden. Het observeren en begrijpen van deze processen helpt om teams effectief te laten functioneren en begeleiden. Hierbij wordt gekeken naar gedrag, ontwikkeling, interacties, groepsstructuur, rollen, persoonlijkheden en de manier van samenwerken. Een groep heeft zowel een taakgericht aspect (gezamenlijk doel bereiken) als een sociaal-emotioneel aspect (hoe men samenwerkt).

Inhoud van het College
De volgende onderwerpen komen aan bod:
- De groep
- Ontwikkelfases (Tuckman)
- Groepscohesie
- Roos van Leary
- Leiderschapsstijlen
- Voordelen van groepen
- Voorbereiding groepswerk

Kenmerken van een Groep
Een groep kenmerkt zich door:
- **Een gezamenlijk doel:** Samen bereik je meer dan alleen ("het geheel is meer dan de som der delen").
- **Onderlinge afhankelijkheid:** Leden beïnvloeden elkaar; wat met één persoon gebeurt, heeft impact op de rest.
- **Interactie:** Leden hebben (direct) contact met elkaar, soms ook buiten de groepssessies.
- **Sociale eenheid:** Leden beschouwen zichzelf als onderdeel van de groep (het "wij-gevoel").
- **Wederzijdse beïnvloeding:** De individuen in de groep beïnvloeden elkaars gedrag en houding.

Ontwikkelfases van Tuckman
Groepsontwikkeling verloopt vaak volgens de vijf fases van Tuckman:
1. **Forming (Oriëntatiefase):** Leden kennen elkaar niet, zijn onzeker en afhankelijk van de leider. Verwachtingen zijn onduidelijk. De leider moet structuur bieden, veiligheid creëren en kennismaking faciliteren (bv. door overeenkomsten te zoeken). Leden nemen weinig initiatief. De fase eindigt als leden spontaner worden en meer interactie tonen.
2. **Storming (Conflictfase):** De groep wordt hechter, leden durven zich meer uit te spreken, wat kan leiden tot conflicten over normen, waarden en rollen. Subgroepjes kunnen ontstaan. De leider moet ruimte geven aan conflict, maar dit constructief begeleiden. Het is een normale fase van grenzen aftasten. De leider kan hier sturender/autoritairder optreden en voorbeeldgedrag tonen in conflicthantering. De fase eindigt als de groep zelf conflicten kan oplossen.
3. **Norming (Stabilisatiefase):** Er ontstaat overeenstemming over doelen, werkwijzen, normen en regels. Samenwerking verbetert, leden staan open voor elkaars ideeën en er ontstaat een sterk "wij-gevoel". De groep wordt doelgerichter. De leider kan meer autonomie geven en zich richten op het versterken van de groepscohesie.

4. **Performing (Prestatiefase):** De groep functioneert als een eenheid, is proactief, betrokken en autonoom. Iedereen weet wat er verwacht wordt en werkt efficiënt samen aan het doel. De leider heeft een minimale rol, meer op de achtergrond, en ondersteunt waar nodig bij het optimaliseren van de samenwerking. Het belonen van prestaties is hier op zijn plaats.
5. **Adjourning (Afscheidsfase):** De groep wordt opgeheven. Het is belangrijk hier aandacht aan te besteden, omdat dit voor sommigen als een verlies (rouw) kan voelen. Reacties variëren van extra inzet tot terugtrekking. De leider faciliteert het afscheidsproces door het einde aan te kondigen, een officieel afscheidsmoment te plannen, terug te blikken op de gezamenlijke ervaringen en te helpen bij het plannen van vervolgstappen.

Groepscohesie
Groepscohesie is de bindende factor binnen een groep, het "wij-gevoel". Belangrijke elementen zijn:
- **Voldoende onderling vertrouwen (veiligheid):** De basisvoorwaarde.
- **Overeenkomsten:** Herkenning in elkaar (bv. dezelfde aandoening zoals hartfalen, gedeelde ervaringen).
- **Aanvaardingscohesie:** Het gevoel erbij te horen ("sense of belonging").
- **Taakcohesie:** Aantrekkelijkheid van het gezamenlijke doel en de taken.
- **Holding cohesie:** Een veilige en duidelijke structuur, genormaliseerde patronen.
- Cohesie is merkbaar in de interacties (oogcontact, hulpvaardigheid) en beïnvloedt het behandelresultaat positief. Het is belangrijk om cohesie vroeg in het groepsproces te versterken. Het concept is gerelateerd aan hechtingstheorie (Bowlby) en werd als term geïntroduceerd door Kurt Lewin.

Factoren die Cohesie Beïnvloeden (o.a. in Sportteams)
- Deze factoren beïnvloeden samen het "wij-gevoel" en daarmee de prestaties.
  - Omgevingsfactoren: Contractuele aspecten, groepsgrootte (kleinere groepen vaak cohesiever), fysieke nabijheid, onderscheidend vermogen van de groep.
  - Leiderschapsfactoren: Stijl van de leider (bv. democratisch vs. autoritair), de relatie tussen leider en groep.
  - Teamfactoren: (In)formele rollen binnen de groep, groepsnormen, communicatiepatronen, gezamenlijke doelen, groepsprocessen.
  - Persoonlijke factoren: Individuele tevredenheid, motivatie, (faal)angst, gedeelde verantwoordelijkheid. Een risico hier is *social loafing*: de neiging minder inzet te tonen in een groep omdat men denkt dat anderen het wel oppakken.

Relatie Cohesie en Prestatie
De beste groepsprestaties worden bereikt wanneer zowel de groepscohesie (het "wij-gevoel") als de groepsnorm voor productiviteit (de wil om het doel te bereiken) hoog zijn.

Group norm for productivity	Group cohesion High	Group cohesion Low
High	**Beste Performance**	Intermediate performance
Low	Worse performance	Intermediate performance

Roos van Leary
De Roos van Leary, ontwikkeld door psycholoog Timothy Leary (ca. 1957), is een model dat inzicht geeft in interactiepatronen: hoe gedrag van de één gedrag bij de ander oproept.

- Het model toont 8 communicatiestijlen.

Het is gebaseerd op twee relationele assen/verlangens:

- **Invloed (Boven/Onder):** De mate waarin men de ander wil sturen of volgen.
- **Nabijheid (Samen/Tegen):** De mate waarin men contact en acceptatie zoekt of juist afstand creëert.

Belangrijke interactieprincipes ("wetmatigheden"):

- **Boven-gedrag roept Onder-gedrag op (en vice versa):** Leidend gedrag lokt volgend gedrag uit; afhankelijk gedrag lokt initiatief uit.
- **Samen-gedrag roept Samen-gedrag op:** Helpend gedrag lokt meewerkend gedrag uit.
- **Tegen-gedrag roept Tegen-gedrag op:** Agressief gedrag lokt defensief of agressief gedrag uit.
- De Roos van Leary diagram met assen Boven/Onder (dominantie) en Tegen/Samen (relatie) en 8 gedragssegmenten: Concurrerend, Leidend, Helpend, Meewerkend, Afhankelijk, Teruggetrokken, Opstandig, Agressief]
- **Verticale as (Dominantie):** Boven (leidend, concurrerend) vs. Onder (afhankelijk, meewerkend, teruggetrokken).
- **Horizontale as (Relatie):** Samen (helpend, meewerkend) vs. Tegen (agressief, opstandig, concurrerend, teruggetrokken).
- **Gedragssegmenten:** Leidend, Helpend, Meewerkend, Afhankelijk, Teruggetrokken, Opstandig, Agressief, Concurrerend.

Belangrijk: Geen enkel gedrag is per definitie goed of slecht; de effectiviteit hangt af van de context. Iedereen beschikt over alle gedragingen. Het is positief als het gedrag bijdraagt aan het groepsproces.

- **Leiderschapsstijlen**
  Er zijn verschillende leiderschapsstijlen, waaronder:
- **Autoritaire leider:** Geeft bevelen, bepaalt doelen en instructies, neemt beslissingen alleen. Kan nuttig zijn in de beginfase (Forming) voor structuur. Kan leiden tot meer agressie in de groep.
- **Democratische leider:** Betrekt de groep bij besluitvorming, houdt rekening met gevoelens en behoeften, let op het groepsproces. Wordt vaak als sympathieker ervaren en leidt doorgaans tot hogere tevredenheid, vooral in kleine, interactieve groepen.
- **Laissez-faire leider:** Neemt geen deel aan besluitvorming, houdt afstand, is passief en toegeeflijk, laat de groep zelfstandig opereren.

Context is Cruciaal: Hoewel de democratische stijl vaak de voorkeur heeft, is er geen universeel beste stijl. De meest effectieve leiderschapsstijl hangt af van de situatie, de groep en het doel (situationeel leiderschap). Ook een autoritaire aanpak kan soms nodig of effectief zijn.

- **Voordelen van Werken in Groepen**
  Groepswerk (bv. in de zorg) biedt diverse voordelen voor deelnemers:
- **Aanvaarding:** Het gevoel geaccepteerd te worden zoals men is, met beperkingen.
- **Universalisme:** Het besef niet alleen te staan in problemen of ervaringen ("lotgenotencontact"), wat eenzaamheid vermindert en verbondenheid versterkt.
- **Altruïsme:** De mogelijkheid anderen te helpen, wat een goed gevoel geeft ("wie goed doet, goed ontmoet").
- **Hoop:** Het zien van vooruitgang bij anderen kan inspireren en hoop geven.
- **Begeleiding:** Onderlinge steun en advies.
- **Leren van voorbeeldgedrag:** Leren door observatie van anderen.
- **Leren door inzicht:** Nieuwe perspectieven krijgen op eigen situatie.

- **Leren door feedback:** Constructieve terugkoppeling van groepsleden en leider.
- **Zelfonthulling:** De mogelijkheid om persoonlijke ervaringen te delen in een veilige, begripvolle omgeving, wat makkelijker gaat met mensen die hetzelfde meemaken.

Voorbereiding van een Groep

Bij het opzetten van een groep is een goede voorbereiding essentieel:

1. **Doelgroep concretiseren:** Wie zijn de deelnemers? (bv. leeftijd, aandoening, geslachtsmix)
2. **Groepsdoel concretiseren:** Wat wil je met de groep bereiken? (bv. conditieverbetering, herstel, behoud)
3. **Werkwijze concretiseren:** Hoe ga je te werk? Welke methoden?
4. **Taak van de groep:** Wat gaan de deelnemers concreet doen? Welke activiteiten?
5. **Vormgeving:** Praktische aspecten:
   - Groepsgrootte
   - Open (nieuwe instroom mogelijk) of gesloten groep?
   - Duur, frequentie en intensiteit van de bijeenkomsten (intensiteit individueel of groepsbreed?).
6. **Evaluatie/resultaat:** Hoe worden de voortgang en resultaten gemeten?

Na de Voorbereiding:

- Selectie: Hoe worden deelnemers geselecteerd (bv. via intake)?
- Omgaan met angst: Hoe wordt eventuele angst bij deelnemers aangepakt?
- Regels: Welke (gedrags)regels zijn nodig voor een veilige en productieve omgeving?
- Dit college biedt een basis voor het begrijpen en begeleiden van groepen, wat direct toepasbaar is in de praktijk en bij het leiden van oefengroepen.

GC COLLEGE WEEK 5

College 3: Psychosociale factoren bij hartproblematiek
Dit college behandelt de psychosociale aspecten die een rol spelen bij patiënten met hartproblematiek. De focus ligt op de psychische dimensie, waaronder de rol van controle, therapietrouw (compliance), cognities, emoties en persoonlijkheid.

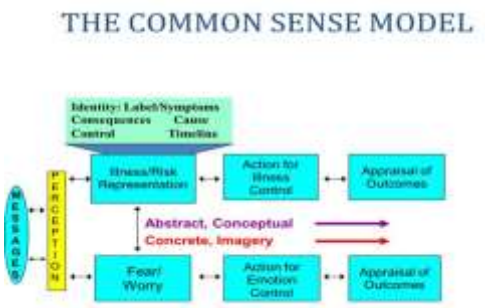
Psychische dimensie van hartproblemen
De volgende onderwerpen komen aan bod:
- De rol van controle
- Non-compliance (therapie-ontrouw)
- Cognities (denkpatronen)
- Emoties
- Persoonlijkheid

De rol van controle
- **Definitie:** De mate waarin een patiënt ervaart zelf invloed te kunnen uitoefenen op het verloop van zijn aandoening.
- **Bij hart- en vaatziekten:** Deze aandoeningen zijn ten dele gedragsmatig bepaald. Het aanpassen van ongezond gedrag (leefstijl: voeding, roken, drinken, sporten) biedt een realistische mogelijkheid om controle uit te oefenen en verergering of recidief tegen te gaan. Volledige controle is echter niet mogelijk.
- **Opleidingsniveau:** Hoger opgeleiden ervaren vaak een groter gevoel van controle over hun klachten dan lager/praktisch opgeleiden, mogelijk door beter begrip of toegang tot middelen (Ranchor en Sanderman, 2000). Praktisch opgeleiden vinden het soms lastiger te bepalen hoe ze controle kunnen uitoefenen.
- **Illusie van controle:** Dit is het overschatten van de eigen controle (soms een "fighting spirit"). Een voorbeeld is denken dat men heel gezond eet, terwijl dit door verborgen vetten of gebrek aan kennis over voeding tegenvalt. Een sterk gevoel van controle kan het welbevinden verhogen, maar leidt niet bewezen tot levensverlenging (Taylor, 1984). Het is vooral een subjectief gevoel.

Non-compliance (Therapie-ontrouw)
- **Definitie:** Weerstand van patiënten tegen noodzakelijke aanpassingen in leefstijl, het gebruik van hulpmiddelen (bv. rollator) of het volgen van therapie.
- **Oorzaken:** Negatieve cognities en de ziekteperceptie spelen een belangrijke rol. Patiënten kunnen weerstand hebben omdat verandering afwijkt van hun routine.
- **Common-Sense Model (CSM):** Dit model helpt de ziekteperceptie van de patiënt te begrijpen aan de hand van vijf kernvragen:
    - Wat heb ik? (Identiteit)
    - Wat is de oorzaak?
    - Hoelang gaat het duren? (Timeline - een hartprobleem is vaak levenslang, anders dan bv. een knieklacht)
    - Wat zijn de consequenties? (Werk, sport, leefstijl)
    - Hoe krijg ik er controle op? (Controleerbaarheid)
- **Aanpak:** In een leergesprek is het cruciaal om samen met de patiënt de *door hem/haar ervaren* voor- en nadelen van gedragsverandering op een rij te zetten. Een nadeel kan voor de patiënt zwaar wegen, ook al lijkt het voor de therapeut onlogisch (bv. het missen van sociale momenten tijdens rookpauzes op het werk). Focus op wat de patiënt belangrijk vindt.

Ziektepercepties & Common Sense Model

Diagram van het Common Sense Model dat de relatie toont tussen boodschappen, perceptie, representatie van ziekte/risico, acties (voor ziekte en emotie), en beoordeling van uitkomsten, met elementen zoals identiteit, oorzaak, tijdlijn, consequenties, controle, angst/zorgen.]



Het CSM visualiseert hoe patiënten informatie verwerken en tot actie (of inactiviteit) komen. Het model helpt te analyseren waar percepties, zorgen of belemmeringen liggen. Door te focussen op de *mogelijkheden* die uit deze analyse naar voren komen, is de kans op succesvolle gedragsverandering groter. Veranderen vanuit een wens ("willen") is effectiever dan veranderen vanuit een verplichting ("moeten").

Cognities, Emoties en Persoonlijkheid

Er zijn vijf belangrijke psychosociale domeinen rondom coronaire hartziekten:

- **Depressie:** Zowel een risicofactor voor het ontwikkelen van hartproblemen als een mogelijk gevolg ervan (door de stress van de aandoening).
- **Angst:** Eveneens een risicofactor en een gevolg. Angst voor herhaling (recidief) of paniekaanvallen die lijken op een hartinfarct komen veel voor.
- **Persoonlijkheidsfactoren:** Beschreven via het OCEAN-model (zie hieronder).
- **Sociale isolatie:** Patiënten blijven soms thuis uit angst om buiten de deur een hartprobleem te krijgen en geen hulp te ontvangen.
- **Chronische stress:** Komt veelvuldig voor bij hartpatiënten.

Angst en depressie (Verdieping)

- Cardiovasculaire aandoeningen roepen vaak angst op, wat kan leiden tot vermijdingsgedrag (situaties vermijden die geassocieerd worden met eerdere klachten).
- Patiënten met *hartfalen* lijden significant vaker aan depressie en angst dan andere groepen hartpatiënten.
- Behandelingen zelf, zoals een ICD-implantatie met kans op onverwachte ontladingen, kunnen angst en een gevoel van controleverlies veroorzaken, wat kan leiden tot aangeleerde hulpeloosheid en depressie.

Persoonlijkheid - OCEAN / The Big Five

Persoonlijkheid zelf leidt niet direct tot sterfte, maar beïnvloedt gedragspatronen en emoties die wel risicofactoren kunnen zijn (bv. gedrag voortkomend uit depressie). Het OCEAN-model beschrijft vijf hoofddimensies:

1. **Openheid voor nieuwe ervaringen (Openness):** Hoog = nieuwsgierig, veranderingsbereid; Laag = houdt vast aan routine, moeite met aanpassingen (bv. leefstijl).
2. **Consciëntieusheid (Conscientiousness):** Hoog = gedisciplineerd, georganiseerd; Laag = impulsief, geassocieerd met hoger risico op ongezond/risicovol gedrag (roken, drinken).
3. **Extraversie (Extraversion):** Hoog = sociaal, energiek; Laag = introvert, rustig. Hoge scores soms ook gelinkt aan risicovoller gedrag.
4. **Aangenaamheid (Agreeableness):** Hoog = coöperatief, empathisch; Laag = kritisch, minder meewerkend.
5. **Neuroticisme (Neuroticism):** Hoog = angstig, neiging tot negatieve emoties; Laag = kalm, emotioneel stabiel.

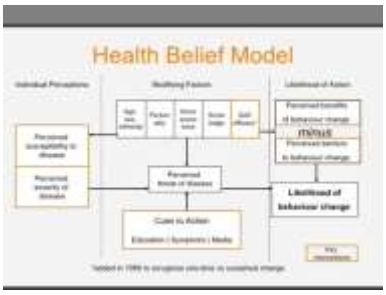
Vitale Uitputting
- **Symptomen:** Extreme vermoeidheid, lusteloosheid, energieverlies, prikkelbaarheid, moedeloosheid.
- **Risico:** Mensen die vitaal zijn uitgeput lopen een *sterk verhoogd risico* op een hartinfarct. Vitale uitputting is mogelijk een *belangrijker voorspeller* dan klassieke risicofactoren zoals leeftijd, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, roken en diabetes mellitus.
- **Relevantie voor Fysiotherapie:** Herken deze symptomen ook bij patiënten met andere (bv. musculoskeletale) klachten, aangezien het een voorbode kan zijn van cardiale problemen. Overweeg verwijzing naar de huisarts bij vermoeden.

Kwaliteit van Leven (KvL)
- **Definitie:** Het functioneren van een persoon op fysiek, psychisch en sociaal gebied, én de *subjectieve evaluatie* daarvan.
- **Subjectiviteit:** Wat een goede KvL is, verschilt per persoon (een 6 kan voor iemand acceptabel zijn). Het is cruciaal om te achterhalen wat voor de *individuele patiënt* belangrijk is op elk van deze domeinen. Een beperking (bv. minder fysieke activiteit) hoeft niet per se tot lage KvL te leiden als andere domeinen (bv. sociale contacten, hobby's) nog bevredigend zijn. Therapiedoelen moeten hierop aansluiten.

Hartrevalidatie - Algemeen
- **Vorm:** Veelal groepsrevalidatie, vaak ingedeeld naar inspanningsniveau.
- **Focus:** Gericht op de *individuele doelen* van de patiënt (fysiek, psychisch, sociaal). Geen 'one size fits all'.
- **Doel:** Aanpakken van beïnvloedbaar risicogedrag (bv. inactiviteit, roken, voeding, over-/onderbelasting).
- **Aanpak:** Vaak multidisciplinair (fysiotherapeut, diëtist, psycholoog, maatschappelijk werker, stoppen-met-roken poli).
- **Patiëntenpopulatie:** Divers (na hartinfarct, na PCI/CABG, etc.).

Doelen Hartrevalidatie (KNGF Richtlijn Coronairlijden 2024)
Zes kerndoelen voor patiënten met coronairlijden:
- Leren kennen van eigen fysieke grenzen (bv. m.b.v. Borg-schaal tijdens inspanning).
- Leren omgaan met fysieke beperkingen (bv. activiteiten pacen, luisteren naar signalen).
- Optimaliseren van het inspanningsvermogen (binnen de resterende capaciteit).

- Overwinnen van angst voor lichamelijke inspanning (vooral indien het event tijdens inspanning plaatsvond).
- Ontwikkelen/onderhouden/hervatten van een lichamelijk actieve leefstijl (veilige opbouw).
- Optimaliseren van werkhervatting (indien van toepassing, rekening houdend met werkeisen, ook voor jongere patiënten).



Health Belief Model (HBM)
- **Basisprincipe:** Mensen veranderen hun gezondheidsgedrag pas als ze een *gezondheidsdreiging* ervaren. Deze dreiging hangt af van:
  - Waargenomen *vatbaarheid* voor de aandoening.
  - Waargenomen *ernst* van de aandoening.
- **Voorwaarde voor actie:** De waargenomen *voordelen* van de gedragsverandering moeten opwegen tegen de waargenomen *nadelen* of barrières.
- **Noodzaak:** Zonder ervaren noodzaak is duurzame gedragsverandering moeilijk (cfr. falende nieuwjaarsvoornemens, uitstelgedrag bij studie).
- **Componenten (zie** Individuele percepties, beïnvloed door modificerende factoren (demografie, kennis, etc.), leiden tot waargenomen dreiging. *Cues to action* (interne signalen zoals symptomen, of externe zoals educatie, media, voorbeeld 'piano trap' op station) kunnen aanzetten tot actie, mits de baten > lasten zijn. Kennis is een belangrijke modificerende factor.

Hartrevalidatie Doelen - Specifiek
- **Fysiek:** Leren omgaan met somatische grenzen, (hernieuwd) vertrouwen krijgen in eigen lichaam, optimaliseren inspanningsvermogen. Kan ook diagnostisch gebruikt worden (bv. voortgang meten met testen).
- **Mentaal:** Overwinnen van angst voor inspanning (actief bespreken!), herwinnen van emotioneel evenwicht, ontwikkelen van een functionele manier van omgaan met de hartziekte (balans vinden, niet alles-of-niets).
- **Sociaal:** Optimale hervatting van werk en vrijetijdsbesteding. Cruciaal hierbij is *lotgenotencontact*: het delen van ervaringen en strategieën binnen de groep werkt vaak zeer ondersteunend.
- **Secundaire Preventie:** Uitleg over risicofactoren (herhaling voorkomen), hulp bij stoppen met roken, stimuleren van een lichamelijk actieve leefstijl, bevorderen van een gezond voedingspatroon, verbeteren van therapietrouw t.a.v. medicatie (regelmatige checks bieden structuur).

Hartrevalidatie Processen
- **Inzicht geven in trainbaarheid:** Wat kan ik aan in het dagelijks leven? Wanneer rust nemen, wanneer kan er meer?
- **Inzicht geven in lichaamsgevoel, balans en vertrouwen:** Bewustwording van het lichaam.
- **Ontspanningsinstructies:** Gericht op lichaamsbesef en het leren bewust ontspannen (aandacht naar binnen). Werkt vaak goed, ook bij sceptische patiënten, en biedt tools voor stressmanagement thuis/werk.
- **Cognitieve herstructurering:** (Impliciet) Helpen om niet-helpende gedachten over de ziekte en inspanning om te buigen.